طبع فى 11/10/2026 19:48:47

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نصره جمال محمود سعد

المحافظة : القاهره　　**الحي / المدينة :** مصر القديمه　　**العنوان :** مصر القديمه

رقم البطاقة : 28806010108888　　**رقم التليفون :** 01111562257　　**تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 01-06-1988**المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي　　　**المقر بما فيه**

التوقيع:(--------------------------)　　　**التوقيع:**(--------------------------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمده 6 شهور [14163]　　**قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ---------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني　　**الوظيفة:** ---------------------------　　**التوقيع:** د/ كيلانى

الاسم: د/ندى حسن　　**الوظيفة:** ---------------------------　　**التوقيع:** ندى حسن

الاسم: د/نرمين رمضان　　**الوظيفة:** ---------------------------　　**التوقيع:** نرمين رمضان

G R I - E
جوستاف روسي
جوستاف روسي مصر

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ------------------------　**ا.د/** ------------------------　**د/** ------------------------　**د/** ------------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --
خطة العلاج : --
المستشفي : --- **قسم :** ---
جهة العلاج : --- **نفقات :** ---
ملاحظات : --

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: نصره جمال محمود سعد
National ID: 28806010108888

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

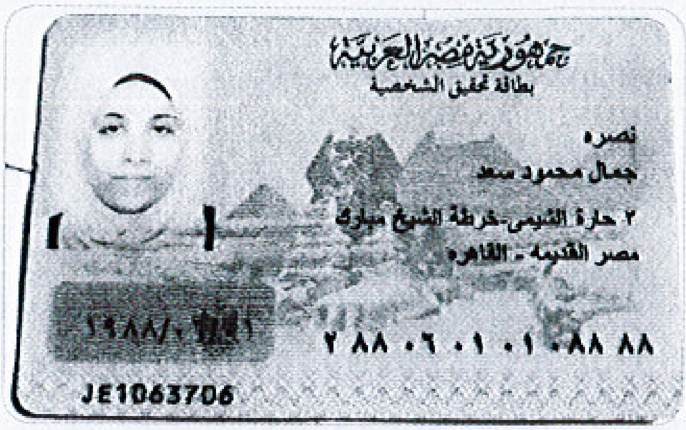
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Goserelin (Zoladex) subcutaneous**

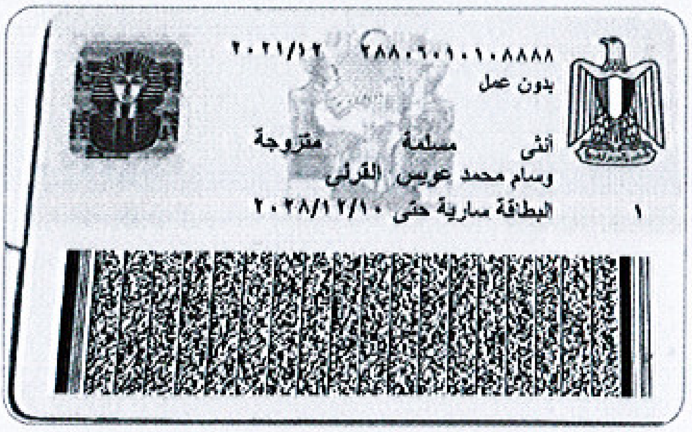
التاريخ : **05-07-2026**	الوقت : **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

نصره
جمال محمود سعد
٢ حارة التيمى-خرطة الشيخ مبارك
مصر القديمة - القاهره

١٩٨٨/٠٦/٠١
٢٨٨ ٠٦ ٠١ ٠١ ٠٨٨ ٨٨
JE1063706



٢٨٨٠٦٠١٠١٠٨٨٨٨ ٢٠٢١/١٢
بدون عمل
أنثى مسلمة متزوجة
وسام محمد عويس القرنى
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١٢/١٠

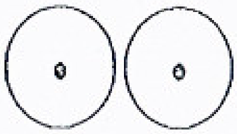
Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

[illegible] جمال

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : نصره كمال محمود سعد
Sex: Female
3- Medical number: 83084524
Old Med : 2663/2022
2-ID number: 28806010108888
Patient Age : 35 Y



Family history
Phone 01156231423 01111562257
BMI
REASON OF MDT POST OPERATIVE
marital status
NRS Score
GROUP B
Date of MDT 04/18/2023
Co morbidity
Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX: IDC	ER: 8/8	PR: 7/8	Her 2 Neu : -VE	SISH :	KI67 : 25%

T	N	M

Sonomammography

LT BREAST: MULTICENTRIC MALIGNANT MASS
RT BREAST: BENGIN CALCIFICATON

PATIENT HISTORY

PT RECEIVED NACT---4AC
4 TAXOTERE TILL (8/2/2023)
PATHOLOGICALLY PARTIAL RESPONSE

MDT OUTCOME & PLAN

FOR AI - ZOLADEX
PORTH

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ شريف عسكري د/ فهد شاهين	RADIOLOGY	د/ عليا جبر 18/04/2023
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

Name: نصره جمال محمود

MR. : 328

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من

بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:

رقم طبي:

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :

تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was placed on adjuvant therapy with letrozole (Femara) and goserelin acetate (Zoladex) beginning in December 2025, together with zoledronic acid (Zometa) administered for six months starting in September 2025.

The patient received neoadjuvant chemotherapy consisting of four cycles of Adriamycin and cyclophosphamide (4AC) followed by four cycles of docetaxel (Taxotere) completed on 2 August 2023, after which a left modified radical mastectomy (MRM) was performed. Post-operative management included adjuvant letrozole and goserelin, with the patient receiving today’s dose of goserelin and letrozole.

The patient has a history of left-sided breast cancer, clinical stage T4b N1 M0, invasive ductal carcinoma, grade 2, estrogen receptor (ER) score 8/8, progesterone receptor (PR) score 7/8, HER2-negative. Neoadjuvant chemotherapy with anthracycline-taxane (AC-T) was administered in February 2023, followed by left-sided surgery. Since March 2023 the patient has been on adjuvant letrozole and goserelin, with the next goserelin dose due on 27 April 2026, and ongoing bisphosphonate therapy with zoledronic acid.

The patient continues adjuvant therapy with letrozole and goserelin; a dose of goserelin was administered in June 2026 today, and letrozole is being taken for a three-month interval.

تحريرا في ,

التاريخ : 21-09-2026

الوقت :

الطبيب المعالج : علياء احمد أبو النصر شهاب الدين

يعتمد ,

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name : الأستاذه / نصره جمال حمود سعد
Patient No. : 28806010108888
Path No. : 1829/22
Sex : Female
Age : 34 Y
Referreing Doc. :

Request No. : 13003722
Request Date : 27/06/2022
Verification Date : 25/07/2022
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

CLINICAL DATA
Left breast mass.

NATURE OF SPECIMEN
Tru cut biopsy.

GROSS PATHOLOGY
Multiple grayish white , fatty and hemorrhagic tissue cores up to 1.5cm, totally submitted.
Immunohistochemical technique: Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (SP1), PR clone (1E2), HER-2 CLONE (4B5), &Ki67 (30-9).

Microscopic examination:
- Histological type: invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1).
- Angioinvasion: No.
- Ductal carcinoma in situ: focal

IPT:

Examination of ER stained slide show intense nuclear staining in 100% of the tumor cells.
Examination of PR stained slide show strong nuclear staining in 60% of the tumor cells.
Examination of HER2 stained slide show no membranous staining in the tumor cells.
Examination of Ki67 stained slide show nuclear staining in 25% of tumor cells.

Positive tissue control showed appropriate reactivity

Diagnosis:

Verified by :
DR.Menna Nabil

Patient Name الأستاذه / نصره جمال محمود سعد
Patient No. 28806010108888
Path No. 1829/22
Sex Female
Age 34 Y
Referreing Doc.

Request No. 13003722
Request Date 27/06/2022
Verification Date 25/07/2022
Financial Category اورام دار السلام - مبادره
Department Out Patient

Registered by Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Left breast mass; Tru cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma GII.
- No Angioinvasion.
- Focal Duct carcinoma insitu.
- IPT:

ER: Positive (score 8/8).
PR: Positive (score 7/8).
HER-2: Negative (score 0).
Ki67: Positive in 25% of tumor cells.

Prof. Dr. Amal Hareedy.

Dr. Menna Nabil.

31/07

Dr.Esraa Magdy.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name : الأستاذه / نصره جمال محمود سعد
Patient No. : 28806010108888
Path No. : 910/2023
Sex : Female
Age : 34 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13001867
Request Date : 22/03/2023
Verification Date : 05/04/2023
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast cancer post NACT

Nature of the specimen:
Left SM & Lt SLN biopsy

Gross Examination:

- Procedure: Left simple mastectomy specimen measured 18.5x16x5cm with covering skin ellipse measured16x9cm .
- Tumor extent : A greyish white fibrous area
- Localization: LOQ
- Size: 8x6x3cm
- Skin involvement: Focal erosion
- Distance from margins: 1 cm away from deep margin and 1 cm away from the skin
- SLNs number and size:Two Fibrofatty tissue piece measured 7x8 cm and 2x3 cm , enclosing 6 SLNs up to 1.5 x2 cm .

Microscopic examination:

- Histological type: No residual viable invasive tumor in breast tissue
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: Evidant 30%
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Showed focal microscopic tumor deposite in 1/6 LNs with therapy changes, no capsular invasion
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy:Near complete Pathologic response

Diagnosis:

Verified by :
Dr.Hebatallah Mostafa

Patient Name	: الأستاذه / نصره جمال محمود سعد	Request No.	: 13001867
Patient No.	: 28806010108888	Request Date	: 22/03/2023
Path No.	: 910/2023	Verification Date	: 05/04/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 34 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Left Simple Mastectomy & Left SLN biopsy (post NACT):
No residual viable Invasive tumor in previous case of IDC,grade II

- DCIS is evidant 30%
- Free margins
- Free nipple and areola
- Positive SLNs (1/6)
- Near complete Pathologic response
- Stage : ypTis , ypN1
- RCB : 1.664 , RCB class II

Signature

Prof. Dr. Iman Gouda
Dr: Hebatallah Mostafa

Verified by :
Dr.Hebatallah Mostafa

Oncology Center
الأورام
NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER
خطابات أورام

وزارة الصحة
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى معهد ناصر
مركز الأورام
Nasser Institute Hospital

NUCLEAR MEDICINE UNIT
وحدة الطب النووي

Patient Name: Nasra Gamal Mahmoud. **Date: 16/10/2022**

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- No definite hot spot that account for active osseous lesions could be detected allover the surveyed skeleton.
- Degenerative changes at the spine.
- Both kidneys are seen.

Conclusion:

- *No definite evidence of metastatic osseous deposits.*

Thanks for referance
Nuclear Medicine Unit

DR/Sherine Mahdy, MD